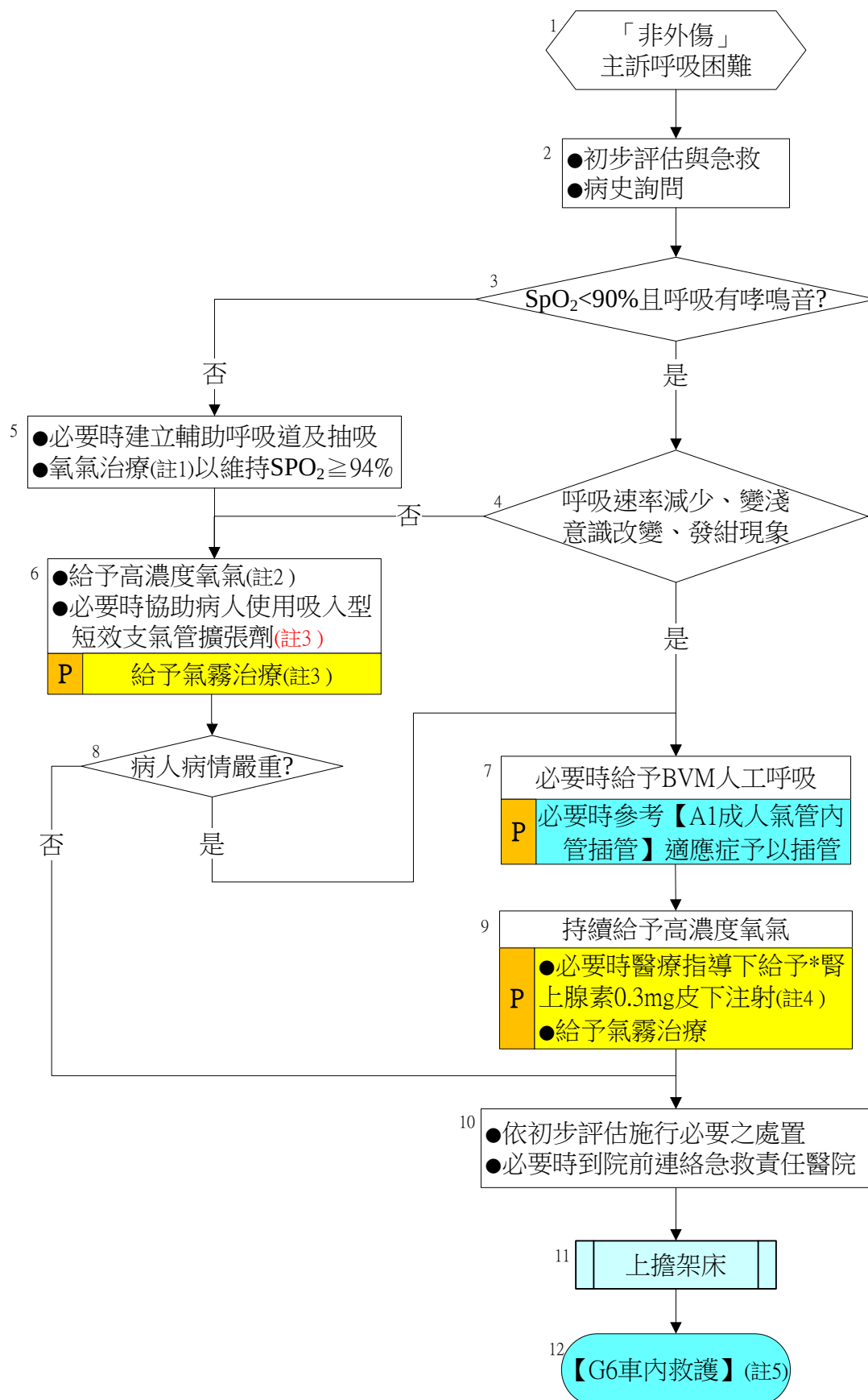


M2 呼吸困難

程 序



要 旨

- 一、主訴「呼吸困難」的病人建議使用本程序：初步評估呼吸 ≥ 30 次/分， < 10 次/分或 $SpO_2 < 90\%$ ，亦建議使用本程序。
- 二、常見呼吸困難的原因，包括呼吸道異物哽塞、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）、肺炎、肺栓塞、肺積水、腫瘤、酸血症、中毒、中樞神經疾病、過度換氣或胸部外傷等。EMT應用給氧方式以維持病人「適當的血氧值」，這些方式包括各種給氧方式（鼻管、面罩、BVM）、輔助藥物、輔助呼吸道、或進階呼吸道。
- 三、不論外傷或非外傷病人，當病人發生休克時，呼吸方面可能接著出問題，EMT應謹慎監視、反覆評估是否需要提升呼吸處置等級。

註 解

註1>

- 一、病人無法維持呼吸道暢通，則使用口咽呼吸道或鼻咽呼吸道。
- 二、氧氣設備之使用，應依病人之呼吸狀況及血氧值（ SpO_2 ），選用適當之氧氣設備。
- 三、病人意識清楚且 $SpO_2 \geq 94\%$ 時，如有氧氣治療需求，可優先選擇較舒適之氧氣鼻導管。
- 四、如病人張口呼吸，不論血氧（ SpO_2 ）濃度為何，應給予氧氣（面罩10公升/分）。
- 五、病人呼吸急促（約30次/分以上時），先給予簡單面罩（10公升/分）或純氧面罩（15公升/分）治療。
- 六、懷疑發紺現象、一氧化碳中毒病人，應給予高濃度氧氣（純氧面罩15公升/分）。
- 七、如確定為慢性阻塞性肺病（COPD），包括慢性支氣管炎、肺氣腫及支氣管擴張症，應小心使用氧氣(過高 SpO_2 容易在此類病人造成呼吸趨力降低，反而抑制自發性呼吸)。
- 八、協助病人坐姿或半坐臥姿。

註2>

呼吸 / 氧氣治療：給予氧氣治療，以維持血氧濃度 $\geq 94\%$ 。

註3>

- 一、EMT2可協助病人使用本人之吸入型短效支氣管擴張劑（Short-acting beta-2 agonist，如Berotec MDI）2劑，間隔1分鐘。若無法立即取得藥品或病人已經自行使用過，則協助

病人迅速就醫。

二、**P** 氣霧治療(EMTP操作)：

(一) 僅限 ≥ 1 歲，且無心肌梗塞病史之病人

(二) 氣管擴張劑使用方式

1、抗膽鹼藥物：Atrovent (ipratropium 0.5mg / 2ml / amp霧化型)

2、 $\beta 2$ 促進劑：

(1) Bricanyl (terbutaline 5mg / 2ml / amp 霧化型)

(2) Ventolin (albuterol 5mg / 2ml / amp 霧化型)

(3) Salbutamol (albuterol 5mg / 2ml / amp 霧化型)

(4) Berotec (albuterol 噴劑型；結合連接瓶後以每次 1 噴之方式請病人吸入。)

3、混合型藥物：混合型藥物：combivent (ipratropium 0.5mg + albuterol 2.5mg/2.5ml/amp霧化型)。

4、上述2類藥物可合併同時給予。方式為抗膽鹼藥物 與 貝他促進劑 各1支混合後，置入小型噴霧器以氧氣流量設定6 L/min給予病人霧化吸入。

5、1至2歲病人給予1/ 2上述藥物劑量，但仍使用N/S稀釋至總量4ml。

6、此治療應與運送同時進行，EMT-P不可因試圖給予此治療而延遲送醫。

註4>

一、坐臥方式送醫。

二、**P** 考慮*皮下注射腎上腺素 (epinephrine)：

若病情甚為嚴重，迅速與醫療指導聯絡。在醫療指導下可使用皮下注射1:1000濃度之epinephrine 0.3-0.5mg，每15-20分鐘給1次，直到總共給予3個doses。(注意：45歲以下，無心臟病、高血壓、心律不整或頻脈($\geq 150/\text{min}$)時，才可使用皮下注射。)

註5>

一、高濃度氧氣治療病人，上救護車後若 SpO_2 仍 $< 90\%$ 且**意識惡化**時，應改以BVM人工呼吸，並每 2分鐘檢測1次生命徵象。

二、對疑為心因性氣喘者，例如有明顯端坐呼吸無法平躺、下肢水腫、呼吸音有濕囉音等情形，不應給予靜脈注射。